

小樽の医療のこれからを考える

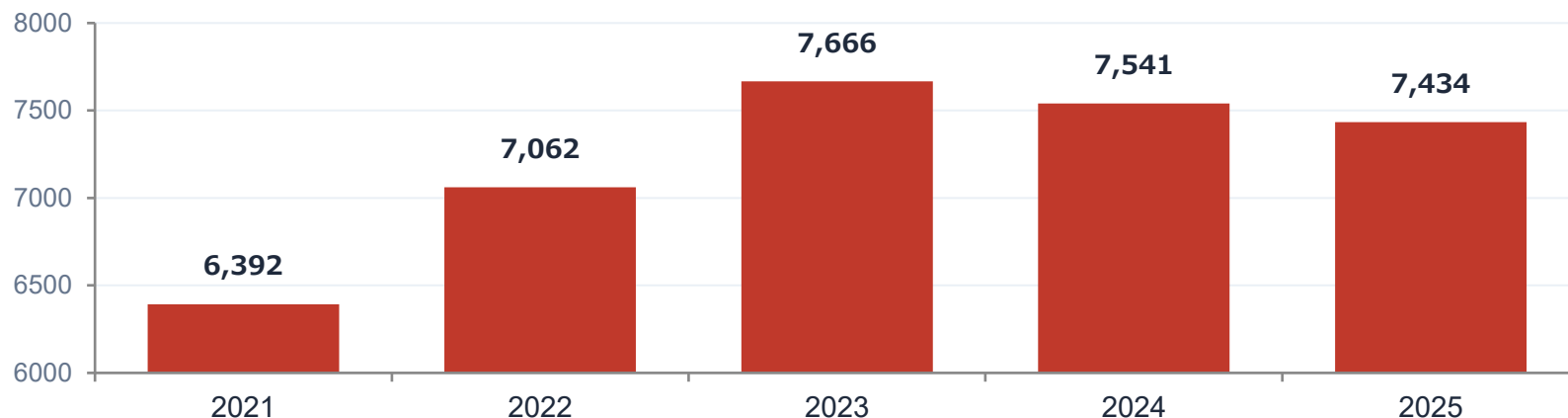
生活破綻型救急が示す、 地域包括ケアが成立しない社会

social inclusion を達成するための前提条件

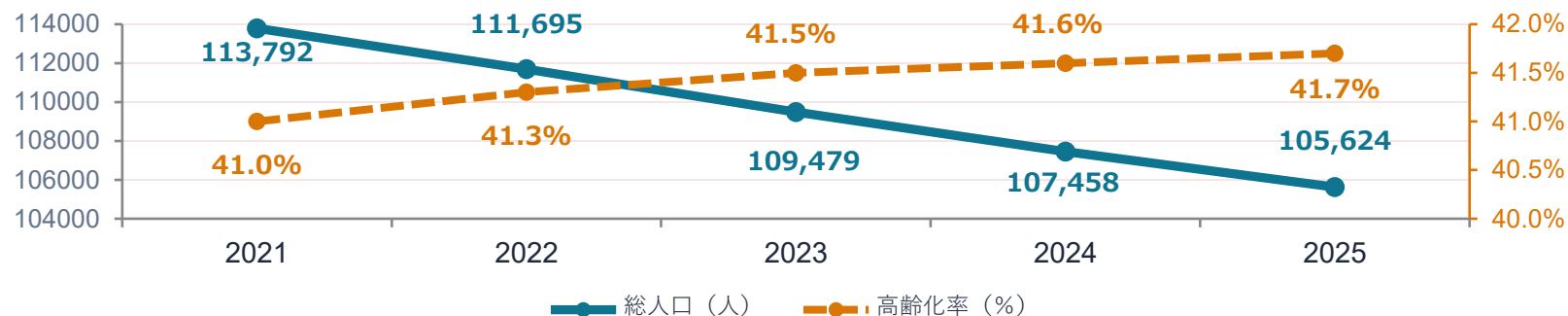


対象期間：2021-2025年

救急搬送件数（件・救急車）



総人口（人・左軸）と 高齢化率（％・右軸）



▲ 8,168人

総人口の減少

2021年 → 2025年
113,792人 → 105,624人

+ 約16%

救急搬送件数の増加

2021年 → 2025年
6,392件 → 7,434件

軽症搬送の増加

搬送の中身

増えているのは軽症搬送

① 生活破綻とは何か

生活破綻 = 生活を営むための機能が失われ、生活を送れなくなること

生活の継続性が途絶える

- ・ 食べる、飲む、動く、排泄する、話す
- ・ 掃除、服薬・金銭管理、危険回避

その結果、
脱水・転倒・体動困難などで救急搬送に至る

生活機能の喪失

- ・ 治療だけでは生活に戻れない
- ・ 生活再建に長期間を要する
- ・ 入院中も機能は低下し続ける
- ・ 役割・人間関係・生活の場を失う

○ 生活破綻の本質

身体・精神・社会的機能が連鎖的に崩れ、自らの力で生活を営むことができなくなる状態

② Agency：主体的決定能力

Agency：主体的決定能力とは

自らの意思で、判断・選択し、それを行動に移す能力

= 生活を営む力

生活破綻は、Agency（主体的決定能力）の低下・喪失に基づく

- ・ 目的がなくなる
- ・ 自助の活動がなくなる
- ・ 意思が曖昧になる
- ・ 助けを求められなくなる
- ・ 危機を認識できなくなる
- ・ 行動できなくなる

→ 気付かぬうちに生活は破綻していく

Agency低下の早期発見が、生活破綻予防に不可欠

③ 個人の損失

生活破綻は、本人の尊厳そのもの（=Agency）を奪う

- ・ 判断・意思表示ができない
- ・ 助けを求められず、孤立・孤独死のリスクが上がる
- ・ 主導権を失い、命の決定権が家族に移る
- ・ 結果：「望まない延命」や「自分らしい生活の喪失」

『ACP：Advance Care Planning』も『Agency』がなければ成立しない

➡ 主体性という尊厳を奪われた数年間——それを幸せだと言えますか？

④ 生活破綻が生む社会的・経済的損失

生活破綻は、本人だけでなく地域の財政に莫大な損失をもたらす

- ・ Agencyの低下・喪失 → 医療・介護需要の急増↑
- ・ 救急搬送・社会的入院・訪問診療などの診療費の増大↑
- ・ ヘルパーや訪問診療などの社会資源の急速な消費（枯渇）↓
- ・ 行政コスト増：家屋の取り壊しや生活保護など

1人あたり、 数百万～数千万円/年

小樽市全体では、 数十億～百億円以上の規模に拡大



→ 生活破綻は、まちの財政を確実に削っていく

⑤

現行システムでは、生活は守られない

医療

病気だけを診て薬で解決、疾患は治っても生活は壊れる

介護

事後介入、代行に偏り、役割と Agency を奪う

包括支援センター（小樽市）

生活破綻を未然に防ぐ取り組みがない

⑥ どうすれば生活破綻を防げるか

必要なことは、

- ・ 早期発見 生活機能の低下に気づく仕組み
- ・ 早期介入 破綻する前に支援できる仕組み
- ・ 相談窓口 本人も家族も迷わず辿り着ける場所
- ・ 対応策 生活を立て直す具体的な手段



人の港を。

港のまちに、

がんばる日も、
うまくいかない日も、
ここにきてください。

小樽に、誰もが立ち寄れる
「人の港」ができます。

2027.9 OPEN 濟生堂小樓病院



→ 早急に整備しなければ、生活破綻者は増え続ける

⑦ 介入すべきタイミング

- ・デッドライン：Agency(主体性)が低下し始めた時点
- ・遅すぎる介入：Agency喪失後では、回復はほぼ不能
- ・望ましい介入時期
「定年後 ～ まだ元気に見えるが生活機能が落ち始めた時期」
- ・即時介入の事例：受診・服薬の遅延、買い物や光熱・水道費支払い・サブスク管理の困難化、外出減少、家事の放置、孤立機会の増加

➡ 元気なうちにしか、介入は意味をなさない

⑧ フレイルの再定義：「衰え」ではなく「生活破綻の手前」

従来の定義

加齢に伴い心身が衰えた状態

Robust (健常) $\leq$ Frailty (フレイル) < Disability (要介護)

逆定義 → 生活破綻未満の状態をフレイルと定義

- ・生活のセルフマネジメントができなくなりつつある状態
- ・生活破綻の手前
- ・介護保険の対象外 = 【空白の層】 → **フレイル：生活破綻予備軍**

○ 生活の段階と制度

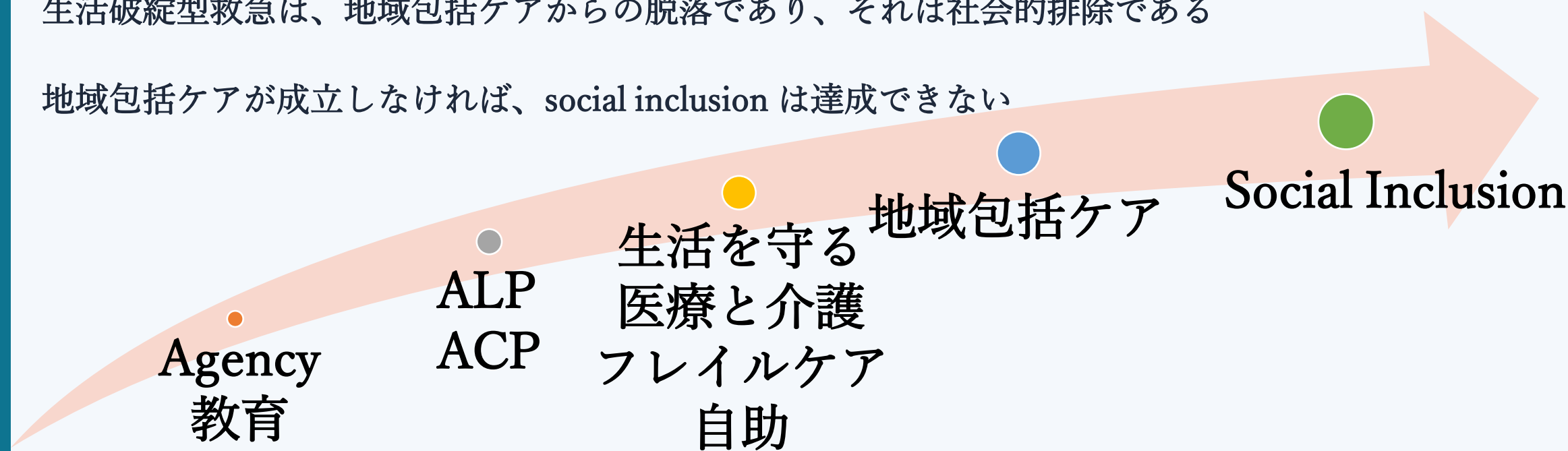


⑨ 真の地域包括ケアの実践

Agency を維持し、生活破綻をさせない取り組み

生活破綻型救急は、地域包括ケアからの脱落であり、それは社会的排除である

地域包括ケアが成立しなければ、social inclusion は達成できない



➡ 地域包括ケアの実装が、social inclusion の前提条件

生活を守る文化を、小樽から

- ・ 小樽はすでに2040年問題といわれる人口構成に突入し、国の施策を待つのでは間に合わない
- ・ Agency：主体的に生活を営む力を維持し、生活を守り続けられる社会へと文化変容しなければ、まちの持続性そのものが危ぶまれる
- ・ 生活破綻を起こさないように、自助・互助・共助・公助を発揮できる社会の場が求められる
- ・ みなが社会の一員であり続けるためには、Agencyと生活が守られることが不可欠である

➡ 地域包括ケアが実践できる社会が、social inclusion への第一歩